Inhibítory SGLT2 u starších pacientov s chronickou chorobou obličiek

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 14.11.2026



Ilustrácia konzultácie o liečbe vytvorená pomocou umelej inteligencie.

U veľmi starých pacientov s chronickou chorobou obličiek (CKD) sa začatie liečby inhibítorom SGLT2 spájalo s nižšou úmrtnosťou v retrospektívnej analýze TriNetX. Druhá analýza opísaná v Medscape upozornila na menej zaznamenaných diagnóz demencie u starších pacientov s diabetom 2. typu. Ide o dve odlišné otázky s odlišnými porovnávacími skupinami. Pri oboch záveroch treba zohľadniť rozdiely medzi reportážou a verejne dostupnými kongresovými abstraktmi [1, 2, 3].

Úmrtnosť vo veľmi vysokom veku

Doricic a spoluautori porovnali pacientov vo veku približne 80 rokov a viac s CKD, ktorí začali užívať inhibítor sodíkovo-glukózového kotransportéra 2 (SGLT2), s pacientmi bez tejto liečby. Po párovaní podľa pravdepodobnosti začatia liečby mala každá skupina 23 765 pacientov. Párovanie zohľadňovalo pridružené ochorenia, laboratórne údaje a dostupné ukazovatele krehkosti. Počas dvojročného sledovania bol upravený pomer hazardov (aHR) pre úmrtie z akejkoľvek príčiny 0,734 (95 % interval spoľahlivosti od 0,705 do 0,765). Pre závažné nepriaznivé obličkové príhody uvádza kongresový abstrakt aHR 0,775 (od 0,745 do 0,806) [2].

Pomer hazardov vyjadruje relatívne porovnanie počas sledovania. Bez údajov o absolútnom riziku z neho nemožno odvodiť, koľkým úmrtiam by liečba zabránila. Aj po párovaní mohli liečení a neliečení pacienti vykazovať rozdiely v miere krehkosti, prognóze či intenzite starostlivosti. Podľa reportáže analýza vylučovala okrem iného pacientov s eGFR najviac 20 ml/min/1,73 m², pacientov liečených dialýzou a príjemcov transplantovanej obličky [1, 2].

Kardiovaskulárne výsledky sa v zdrojoch rozchádzajú

Pre zložený ukazovateľ závažných nepriaznivých kardiovaskulárnych príhod (MACE) uvádza abstrakt ASN aHR 0,884 (95 % interval spoľahlivosti od 0,857 do 0,913). Medscape uvádza aHR 1,007 (p = 0,84). Z dostupných

podkladov sa nedá určiť, či sa líšila definícia ukazovateľa alebo verzia analýzy. Reportáž navyše opisuje vyšší výskyt niektorých samostatných udalostí vrátane infarktu myokardu a akútneho srdcového zlyhávania. Bez podrobného opisu analýzy a overenia výsledkov nemožno tieto údaje považovať za dôkaz škodlivého účinku liečby [1, 2].

Demencia a mierna kognitívna porucha

Medscape opisuje porovnanie nových používateľov inhibítorov SGLT2 a inhibítorov dipeptidylpeptidázy 4 (DPP-4) v databáze TriNetX. Z 43 005 pacientov vo veku aspoň 65 rokov s diabetom 2. typu malo 25 025 vstupnú CKD. V tejto podskupine reportáž uvádza pre zložený ukazovateľ diagnózy demencie alebo miernej kognitívnej poruchy pomer subdistribučných hazardov (sHR) 0,76 (p = 0,003) po zohľadnení úmrtia ako konkurenčnej udalosti. Pre samotnú demenciu uvádza sHR 0,73 bez hodnoty p a pre samotnú miernu kognitívnu poruchu sHR 0,93 bez štatisticky významného rozdielu [1].

Verejne dostupný abstrakt Banoovej a Koraishyho opisuje jedno pracovisko, 969 pacientov a porovnanie s inými liekmi na zníženie glykémie. V analýze zohľadňujúcej úmrtie uvádza sHR 0,49 (95 % interval spoľahlivosti od 0,24 do 1,00, p = 0,051). Tento abstrakt nepotvrdzuje čísla z národnej analýzy opísanej v Medscape. Kódy diagnóz navyše zachytávajú zaznamenanie poruchy, pričom neukazujú, ako sa menil výkon v štandardizovaných kognitívnych testoch. Podobnú asociáciu s diagnózou demencie zistila juhokórejská kohorta pacientov vo veku 40 až 69 rokov. Obe pozorovania podporujú ďalší výskum. Prevenciu demencie inhibítormi SGLT2 zatiaľ nepreukazujú [1, 3, 4].

Čo zohľadniť pri rozhodovaní o liečbe

Pri rozhodovaní o nefroprotektívnej liečbe má väčšiu výpovednú hodnotu randomizovaná štúdia DAPA-CKD. Jej vopred plánovaná analýza podľa veku nenašla dôkaz, že by sa účinok dapagliflozínu menil s vekom. Štúdia zahŕňala pacientov s eGFR od 25 do 75 ml/min/1,73 m² a pomerom albumínu ku kreatinínu v moči (ACR) od 200 do 5 000 mg/g. Výsledky preto treba u veľmi krehkých pacientov posudzovať podľa toho, do akej miery sa podobajú účastníkom skúšania [5].

Podľa KDIGO patrí medzi indikácie diabetes 2. typu s CKD pri eGFR aspoň 20 ml/min/1,73 m². KDIGO odporúča liečbu aj dospelým s CKD pri eGFR aspoň 20 ml/min/1,73 m² a ACR aspoň 200 mg/g alebo pri srdcovom zlyhávaní bez ohľadu na albuminúriu. U staršieho pacienta má zmysel posúdiť stav hydratácie a krvný tlak vrátane ťažkostí pri vstávaní, súbežné užívanie diuretík a schopnosť dodržať pokyny pri akútnom ochorení. Podľa KDIGO je rozumné liečbu dočasne prerušiť pri dlhšom hladovaní, v súvislosti s operáciou alebo pri kritickom ochorení, keď stúpa riziko ketózy. Kognitívne pozorovania z kongresu indikácie nerozširujú [1, 5, 6].

Literatúra

1. *Nancy A. Melville. SGLT2 Inhibitors Linked to Survival, Cognitive Benefits in Older Patients With CKD. Medscape. 28. októbra 2026.*
2. *Julian Doricic, Jonas Michael Willerding, Anette Melk, Kai M. Schmidt-Ott, Robert Greite, Wilfried Gwinner, Bernhard M.W. Schmidt. Extending Benefit to the Oldest Old: Efficacy of SGLT2 Inhibitors in Older Adults with CKD. Kidney Week 2026, 24. októbra, abstrakt SA-OR031.*
3. *Ruqiyya Bano, Farrukh M. Koraishy. SGLT2 Inhibitor Use and Incident Cognitive Impairment in Older Adults with Type 2 Diabetes and CKD. Kidney Week 2026, 24. októbra, abstrakt SA-OR032.*
4. *Anna Shin, Bo Kyung Koo, Jun Young Lee, Eun Ha Kang. Risk of dementia after initiation of sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors versus dipeptidyl peptidase-4 inhibitors in adults aged 40-69 years with type 2 diabetes: population based cohort study. BMJ. 2024;386:e079475. DOI · PubMed 39197881*
5. *Margaret K Yu, Priya Vart, Niels Jongs, Ricardo Correa-Rotter, Peter Rossing, John J V McMurray, Fan-Fan Hou, Walter Douthat, Dinesh Khullar, Anna Maria Langkilde, David C Wheeler, Hiddo J L Heerspink, Glenn M Chertow. Effects of Dapagliflozin in Chronic Kidney Disease Across the Spectrum of Age and by Sex. J Gen Intern Med. 2024;39(6):921-930. DOI · PubMed 38097862 · Plný text*
6. *Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117-S314. DOI · PubMed 38490803 · Plný text KDIGO*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=sglt2-starsi-pacienti-ckd · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.